EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 78999
SERVICIO : MEL HOMBRES HSC
FECHA : 2024-02-14 15:31:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: IRMA DEL CARMEN PARADA VERGARA			RUN	: 4.292.509-8
F.Nac	: 28-08-1937	Edad	: 86 AÑOS, 5 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: AGUA BUENA			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 969030789		
Fecha Ingreso	: 2024-02-12	Fecha Egreso	: 2024-02-14 15:31:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R50.9-FIEBRE, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

SEPSIS FOCO URINARIO (E. coli)
BACTERIEMIA POR E. coli
AP: HTA, DMT2, IC, ERC est IV, ACV secuelado, EPILEPSIA secundaria, FA en TACO, Cardiopatía coronaria,

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39-OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CON HISTORIA DE COMPROMISO DEL ESTADO GENERAL DE AL MENOS 5 DÍAS DE EVOLUCIÓN, ACORDE A RELATO DE FAMILIARES CON AUMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL NO CUANTIFICADO, EPISODIOS DE DOLOR ABDOMINAL Y DIARREA (ESCASA), ADEMÁS DE SOMNOLENCIA, BRADIPSIQUIA, BRADILALIA, ADINAMIA Y ASTENIA.
DURANTE INGRESO EN SERVICIO DE URGENCIA SE TOMAN EXÁMENES DE LABORATORIO DONDE DESTACA ELEVACIÓN DE PARÁMETROS INFLAMATORIOS, SIN FUNCIÓN RENAL DE INGRESO, CON EOC FRANCAMENTE HEMATÚRICO. EN VISTA DE FRANCO EPISODIO FEBRIL EN INGRESO DE 39°, SE DECIDE TOMAR HC QUE REPORTA BREVEMENTE (9H) POSITIVO PARA E. COLI EN AMBAS MUESTRAS. ADEMÁS, SE RECIBE UCT QUE REPORTA POSITIVO PARA E. COLI CON ESPECTRO DE SENSIBILIDAD SIMILAR A REPORTADO EN HC. PACIENTE INGRESA CON CEFTRIAXONA (HOY DÍA 3), PRIMER CONTROL (09/02) DE PCR 275 CON GB 15, POSTERIOR PCR 332 CON GB 8 (12/02).
IMÁGENES DE INGRESO ÚNICAMENTE RX DE TX QUE EVIDENCIA FRANCA CARDIOMEGALIA, SIN SIGNOS DE DE FOCO INFECCIOSO FRANCO.
EN VISTA DE CONDICIONES, SE DECIDE INGRESO A SERVICIO PARA MANEJO Y CONTINUIDAD DE ATENCIÓN.

5TO DIA HOSPITALIZADA -- /5°\ DIA CEFTRIAXONA
PCTE EN SALA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, AFEBRIL SIN REQUERIMIENTO DE O2,

SE REVISA SISTEMA SGH, Y FICHA DE PAPEL HSC, SE CONSIGNA INDICACION DE SONDA VESICAL EN OCTUBRE DE 2021, POST HOSPITALIZACION DE SD CORONARIO O ACV, POR RETENCIONES URINARIAS. ACTUALMENTE CONDICION DE PCTE NO AMERITA SU USO, POR LO QUE AYER SE INDICA RETIRO, Y HA PRESENTADO MICCION ESPONTANEA.
PCTE EN SALA TRANQUILA, SIN MOLESTIAS, AFEBRIL, ALIMENTANDOSE OK .
HDN ESTABLE FC 72 --PA 153/88--T 36.2--SAT 92% AMB .
VIGIL, GCS 15, SEMIORIENTADA, RR 2T , MP+ ESTERTORES FINOS BIBASALES, ABD B D I, EXTREM, LEVE HEMIPARESIA BC DER, SIN EDEMA NI SINGOS TVP.

HA EVOLUCIONADO SATISFACTORIAMENTE A TTO ATB CON DESCENSO DE PARAMETROPS INFLAMATORIOS.
POR LO ANTERIOR, SE INDICA ALTA A HODOM PARA COMPLETAR TTO ATB 10 DIAS TOTAL

PLAN DE MANEJO:

COMPLETAR 10 DIAS TOTAL DE ATB
CONTROL POST ALTA POLI MED INTERNA, AL MES DE ALTA HODOM
CONTROLES CRONICOS POR APS
CONTROL SOS VIA URGENCIA

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO ASISTIDO
2. REGIMEN DIABETICO HIPOSODICO ASISTIDO
3. CEFTRIAXONA FRASCO 1 GRAMO; 2 frascos cada 24 hrs. por 10 dias TOTAL via ENDOVENOSA. (HOY 5/10 OK)
4. PARACETAMOL COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS: 2 comprimido cada 8 hrs. via ORAL, SOS SI DOLOR O FIEBRE
5. RESTO TRATAMIENTOS CRONICOS HABITUALES RETOMAR Y MANTENER

EXÁMENES Y RESULTADOS

UC DE INGRESO (10/02/24) : (+) E coli, SENSIBLE CEFTRIAXONA EN USO
HC 1 Y 2 (+) A E. coli SENSIBLE A CEFTRIAXONA EN USO
EX LAB (13/02): CREA 1.2 / PCR 177 (332)/ LACTATO 0.8/ NA 146, K 3.5, CL 111/ LEUCO 7100, HB 10.5, HTO 31.3, PLAQ 137000

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO